



3

56. ÅRGANG | 03 • 2019

ARTIKEL

Tema

Når krisen rammer
– pædagogiske og psykologiske
perspektiver på krisehåndtering

PPT nr. 3-2019

**Belastningspsykologi
– forebyggelse af primær og
sekundær traumatisering af
hjelperne**

Af Rikke Høgsted

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering af hjælpere



Ingen mennesker kan holde til hvad som helst. Alle har et “breaking point” – et punkt, hvor man ikke kan holde til mere. Det ved vi godt, og det er ikke ny viden, men noget man blandt fagfolk har vidst siden Anden Verdenskrig. Frem til da troede man, at man kunne udvælge en helt særlig type soldat, der gennem den helt rigtige træning kunne gøres immun over for krigens barske hændelser. Men militærpsykologiske studier viste allerede dengang, at en hvilken som helst soldat kan bryde sammen under angreb. Om soldaten brød sammen, afhang af kampens intensitet og længden af den tid, soldaten var i krig. Man kom derfor frem til den erkendelse, at psykiske traumer ikke kun ses hos de “svage” eller “skrøbelige”, men også hos den “stærke” og “robuste” ener, for også han eller hun bliver traumatiseret.

*Af Rikke Høgsted, Psykolog og forfatter,
specialist i psykoterapi og psykotraumatologi, Høgsted & Middelboe*

Til trods for, at vi har haft denne viden i så mange år, hersker der fortsat den myte på mange omsorgsarbejdspladser, at den rigtige fagperson er ham eller hende, der aldrig bryder sammen og bare vedbliver at holde til presset. Det kan dreje sig om den “rigtige” psykolog, socialrådgiver, sagsbehandler, sygeplejerske, SOSU, sundhedsplejerske eller medarbejder på bostedet. Det kan også dreje sig om myten om den almægtige leder – den “rigtige” leder. Ham eller hende, der udover aldrig at bryde sammen selv, har så brede skuldre og forvalter sin magt så elegant, at han eller hun både kan løse kerneopgaverne perfekt, og hvis team er i evig travlhed og aldrig har samarbejdsproblemer. Begge myter fortæller os, at nogle ansatte til trods for årelang konfrontation med død, lidelse,

traumer, trusler og tragedier ikke lader sig påvirke, men bare holder til det. Vi ved godt inderst inde, at det blot er myter, men forveksler dem alligevel med sandheder. Myterne om den usårlige hjælper og almægtige leder handler om magt, ansvar og skyld.

Magt, ansvar, skyld, skam og afmagt

Magt, ansvar og skyld hænger tæt sammen. Hvis man har magt, har man også et ansvar, og man vil derfor naturligt føle skyld, hvis man ikke har levet op til ansvaret. Man vil som fagpersonen imidlertid ind imellem – og måske ligefrem ofte – være i situationer, hvor man reelt er magtesløs i den forstand, at man ikke kan fjerne “problemet” igen. Følelsen af magtesløshed er barsk og skræmmende, da den kon-

fronterer os med det i livet, vi ikke kan kontrollere og reelt ikke har magt over. Den er et vilkår, som vi ikke skal gøre os forhåbninger om forsvinder.

Mange hjælpere og ledere tager imidlertid ansvaret og skylden på sig, når de tænker, at det nok kunne være gået anderledes, hvis bare de selv havde været bedre, mere erfarne, skarpe, dygtigere eller mere indlevende. Og flere opfinder til lejligheden en form for fantasikollega, som på urealistisk vis altid ved, hvad der skal og kan gøres, og som altid er rolig og fattet. Afmagningsfølelser kan være så smertefulde at rumme, at man så hellere vil føle skyld over ikke selv at være god nok, end at man vil stå ved den afmagt, der er forbundet med det vilkår, at der nogle gange bare ikke er noget at gøre.

Med skyld følger en anden følelse, der for de fleste er endnu mere ubehagelig at rumme – nemlig skam. Hvor følelsen af skyld handler om at svigte sine egne idealer og undlade at gøre det, man tænker, man bør gøre, knytter følelsen af skam sig snarere til én selv som menneske. Skamfølelsen kender vi fra tidligt i livet, når vi som helt små børn føler os afvist eller kommer til kort. Skam er en smertefuld følelse, der for mange er forbundet med følelsen af ydmygelse, krænkelser og af at stå uden for fællesskabet. Skammens modsætning er stolthed, som er den følelse, der opstår, når man lever op til sine egne eller andres forventninger og krav. Skamfølelsen ligger ofte bag både den tyndhudede hjælper eller leders grænseløse indsats og måske medfølgende vrede og bag den tykkhudede hjælper eller leders bagatellisering og måske ligegyldighed. Det kan alt sam-

men ses som ansattes forskellige forsøg på at komme over eller benægte skamfølelsen. At mærke og tale om ens faglige stolthed gør en glad, og kan være en effektiv måde at tanke ny energi på i sløje tider. Men at mærke og tale om ens faglige skam, forekommer mange fagfolk så pinagtigt, at de slet ikke kan bære det.

“Det eneste gode ved skammen er, at dens modsætning er værre: Skamløshed. Skamfølelsen vidner i det mindste om, at vi stadigvæk har nogle stolte, faglige værdier.”

(Høgsted 2018:31).

Når vi som ansatte er magtesløse, men ikke tør indrømme det, vil skyld og skamfølelser ofte ødelægge vores evne til at være i en nærværende kontakt med det menneske, vi går på arbejde for at hjælpe. Personen, vi skal hjælpe, registrerer hurtigt den dårlige kontakt og risikerer med rette at føle sig svigtet af hjælperen. Det bliver let til en negativ selvopfyldende profeti: for at den anden i første omgang ikke skal føle sig afmægtig og alene, vælger hjælperen at tage ansvaret og dermed skylden på sig for noget, han eller hun reelt ikke har magt over. Det føles imidlertid så skamfuldt for hjælperen ikke at have magt over situationen, at han eller hun på et psykologisk plan derfor må trække sig i kontakten.

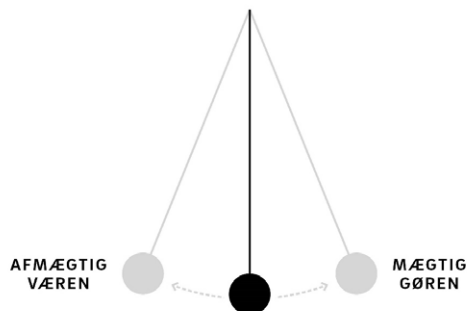
Afmagt er både den mest udfordrende og vigtigste følelse for hjælperen at kunne rumme. Den er udfordrende, idet man som et handlekraftigt menneske er vant til at være den i relationen, der kan og skal gøre noget. Og den er vigtig, fordi man, hvis man ikke

vedstår sig den, ellers risikerer at slide sig selv op i et forgæves forsøg på at redde det, der ikke kan reddes. Eller man risikerer, at man på grund af skyld og skam vender ryggen til de egentlige ofre, der dermed står alene og uden nogen at dele afmagten og smerten med.

Afmagt-magt-pendulet

Som hjælper skal man øve sig i at acceptere, at ens arbejde ufravigeligt vil bringe én i afmægtige situationer, hvor man føler, at ens indsats ikke gør nogen reel forskel. Og der kan da ske det paradoksale, at der, netop qua accepten af afmagten, kan opstå et øjeblik, der faktisk gør en forskel for den anden. Dette fænomen bliver nogle gange omtalt som det bare *at være* sammen med den anden, fremfor *at gøre* noget for den anden. Ordet 'bare' er i denne sammenhæng misvisende, da det får det til at lyde som om, at det er en let ting for hjælperen at gøre. Og intet kan være mere forkert. Væren kan være noget af det hårdeste, når det menneske, man er sammen med, står i en fuldstændig ulykkelig, skrækkelig eller absurd situation, man som hjælper ikke har magt til at ændre på. Det kræver både mental styrke og overskud 'bare at være'.

At hjælpe handler om både at kunne være afmægtig og *være* sammen med den, man skal hjælpe, og om at kunne være mægtig i betydningen at *gøre* noget på baggrund af sin faglige viden. Lige som sørgende pendulerer mellem at konfrontere tabet og undgå tabet – jævnfør de to hollandske sorgforskere Margaret Stroebe og Henk Schuts to-sporsmodel for sorg – beskriver "Af-



Afmagt-magt-pendulet (Høgsted 2019)

magt-magt-pendulet" tilsvarende, hvordan man som hjælper skal kunne veksle mellem at være afmægtig og *være* og at være mægtig og *gøre*.

Væren kan være alt fra det at holde om den anden uden at sige noget, over det at lytte koncentreret til den anden uden at vurdere det, der bliver sagt, til det at sidde helt stille ved siden af den anden og trække vejret sammen. Væren er at sanse stemningen og følelserne i rummet uden at forsøge at lave om på det. Lidt ligesom at være i naturen og sanse og acceptere vejret vel vidende at man ikke kan lave om på det. Eller med præst og forfatter Bent Falks ord at forstå, at trøsten er, at der ikke er noget trøst (Falk 1998).

Gøren kan være alt fra det at sætte ny behandling i gang, over det at vejlede og rådgive eller foreslå et ritual, til det at rejse sig op og skænke den anden et glas vand. Gøren er at være løsningsfokuseret og at skabe sig et vikarierende overblik for det menneske, det par eller den familie, der på grund af det voldsomme eller tragiske, der er sket for dem, selv har mistet det.

Man kan med rette indvende, at væren altid vil indeholde et element af gø-

ren, hvilket er helt korrekt. Gøren og væren kan ses som to sider af samme sag, men vil i øjeblikket ofte føles som forskellige tilstande at være i, både for den der giver, og for den der modtager støtten.

Det store HVORFOR og medfølesestilfredshed

Nietzsches berømte ord: "Den, der ved, hvorfor han lever, kan tåle næsten et hvilket som helst hvordan", kan i denne sammenhæng omskrives til: "Den, der ved, hvorfor han eller hun arbejder, kan næsten tåle et hvilket som helst hvordan". For mange ansatte i et psykisk krævende job handler svaret på spørgsmålet HVORFOR om oplevelsen af at have et meningsfuldt arbejde. Ansatte med stor medfølesestilfredshed – også kaldt compassion satisfaction – og som er glade for deres arbejde med at hjælpe andre mennesker, og som oplever, at de har succes med opgaverne, har en mindre risiko for at udvikle mentale arbejdsskader end dem, der har mindre tilfredshed (Conrad & Kellar-Guenther 2006, Salloum et al. 2015). Der kan være mange forklaringer på dette fænomen, men at huske sig selv og hinanden på HVORFOR, man har valgt sit fag, er en effektiv måde at forbinde sig med den overordnede glæde, taknemmelighed og stolthed ved arbejdet.

Højrisikjob er tit mættet med mening og vil for de ansatte ofte være forbundet med oplevelsen af at have et vigtigt job, hvor man gør en forskel for andre mennesker eller for kloden. Det gør på en gang den ansatte både stærk og svag. Stærk, fordi meningsfuldhed giver mennesker kræfter til at gå en

mil ekstra og ikke give op, når den første modstand viser sig. Men man kan også blive svag. Når man brænder for sit fag, vil der automatisk altid være en sårbarhed forbundet med at have et højrisikjob. Man kan risikere at blive meget selvkritisk, hvis man føler, man ikke personligt slog til i en situation, eller man kan få faglig moralsk stress, hvis man står i en situation, hvor det, man kan tilbyde den anden, ikke er fagligt optimalt eller måske bare fagligt tilstrækkeligt. Bagsiden af faglig stolthed er faglig skam, som er et særdeles ømtåleligt emne, hvis man har et arbejde, hvor ens indsats har direkte konsekvens for et andet menneskes trivsel og/eller liv.

Personlige erfaringer

Der ligger for mange ansatte i et højrisikjob en personlig historie bag valget af fag. Det kan være historien om en moster eller en anden i omgangskredsen, som man så op til, der netop var psykolog, socialrådgiver, pædagog eller lærer. Den personlige historie bag valget af fag og speciale kan også dreje sig om, at man har personlige erfaringer med området. Man har som barn eller ung måske selv lidt af en spiseforstyrrelse, mistet en forælder eller selv vokset op i et hjem med alkoholproblemer og vold. Og måske man den gang følte sig næsten "reddet" af en virkelig god psykolog, lærer, pædagog eller socialrådgiver og derfor nu ønsker at bruge den erfaring til at hjælpe andre børn og unge, der står i samme situation. Eller måske man den gang netop ikke blev "reddet" af nogen og derfor nu vil gøre alt for, at andre børn og unge ikke skal opleve det samme.

Et tæt bånd mellem arbejde og personlig historie kan betyde, at man potentielt kan tilføre faget vigtig viden, da man som "kender" vil kunne forbinde sig mere direkte med arbejdsopgaven. Ingen kan selvfølgelig gå i andres sko, men man kan have en god føling med, hvordan turen er og føles, ser ud, lugter og lyder, hvis man selv en gang har gået en tilsvarende tur i et beslægtet landskab. Personlig erfaring kan på grund af den livshistoriske resonans dog samtidig være ensbetydende med, at de svære hændelser på arbejdet gør større indtryk på én end for andre. Man vil derfor kunne komme i risiko for at blive så overvældet af en patient/klient/borgers situation og enten begynde at overinvolvere sig – i et måske ubevidst ønske om at "redde" den anden – eller i forsvar at underinvolvere sig for at holde ekkoet af fortidens smertefulde følelser på afstand.

"Jeg havde som læge arbejdet med alvorligt syge og døende i mange år, da det på et tidspunkt gik op for mig, at jeg brugte alle mine kræfter på at lindre patienternes smerte og lidelse for ikke at føle min egen."

*Læge på et palliativt afsnit
(Høgsted 2018:136).*

Mangel på personlig erfaring med det område, man arbejder inden for, kan på den ene side begrænse ens udsyn og indsigt, men vil på den anden side ofte give den professionelle en større mental styrke i mødet, da man ikke er bange for at få trigget egen smerte gennem den andens smerte.

Det private HVORFOR

Lige som man kan tale om et arbejdsmæssigt HVORFOR, kan man tale om et privat HVORFOR. Det private HVORFOR handler om, hvilke værdier man som menneske generelt tror på og efterstræber at leve efter. Det er de værdier, man opdrager sine børn ud fra og dem, man bruger at sigte efter i stort som småt. Der vil tit være et stort overlap mellem ens arbejdsmæssige og private værdier, og de vil tit stamme fra helt tidlige oplevelser i ens liv. Man taler nogle gange om ens kerneværdier, som er de, der bliver grundlagt helt tidligt i livet.

"Jeg har ofte tænkt, at der i virkeligheden ikke er noget farligere end at have et meningsfuldt job. For det kan undskylde og begrunde mange kostbare fravalg i ens liv. Hvordan kan noget være vigtigere end at passe en døende patient? Et alvorligt sygt barn? At udføre sit job som den, der beskytter borgerne i samfundet imod terror og andre forbrydelser? Så kan familien og privatlivet blive nødsaget til at vente. Fordi funktionen og tilstedeværelsen på jobbet er så meningsfuld, medmenneskelig og vigtig! Netop fordi arbejdet er meningsfuldt, er det særligt svært at lægge det fra sig og prioritere sine egne behov og sin egen personlige vækst. Behov, som skal opfyldes, for at man fortsat kan fungere som hjælper." (Høgsted 2018:15).

Citatet er af Anders Korsgaard, chefpsykolog på Krisepsykologisk Klinik på Rigshospitalet, fra forordet til min seneste bog *"Belastningspsykologi – fore-*

byggelse af primær og sekundær traumatisering”, hvori begrebet belastningspsykologi introduceres på dansk.

Belastningspsykologi og vejen fra posttraumatisk stressforstyrrelse til sekundær traumatisering

Belastningspsykologi er et overordnet begreb for dels de situationer, der belaster mennesker og dels de reaktioner, der opstår, når et menneske har været udsat for en belastning. Belastningerne kan optræde i privat som arbejdsmæssig sammenhæng og være af både hverdagsagtig karakter og katastrofekarakter. Reaktionerne spænder bredt fra belastningstilstande som for eksempel stress og udbrændthed til egentlig traumatisk betingede psykiske lidelser som for eksempel PTSD og misbrug. En vigtig gren af belastningspsykologien er derfor *psykotraumatologien*, der er den psykologiske disciplin, som beskæftiger sig med forebyggelse, behandling og forskning i de situationer, der traumatiserer mennesker, og de reaktioner, der opstår, når et menneske har været udsat for en traumatisk hændelse.¹

1 Vi har i Danmark tradition for at tale om *krisepsykologi*, som af mange forbindes med den svenske psykiater Johan Cullberg. Han udgav i 1976 bogen “Krise og udvikling”, som professionelle i en lang række omsorgsfag har læst under studierne. Cullberg inddeler i bogen kriser i henholdsvis udviklingskriser, som handler om overgangen fra for eksempel barn til ung eller fra midaldrende til ældre, og traumatiske kriser, der er de psykiske reaktioner, der følger en traumatisk begivenhed. Cullbergs begreb traumatiske kriser hører i sagens natur til belastningspsykologien, hvorimod hans udviklingskriser snarere hører til udviklingspsykologien.

Til trods for at immunitetshypotesen – at nogle mennesker er immune over for ydre pres – faldt helt tilbage i tiden omkring anden verdenskrig, skal vi imidlertid helt op til 1980 før posttraumatisk stressforstyrrelses-diagnosen (PTSD) formelt blev introduceret i det amerikanske diagnosesystem, American Psychiatric Association (1980) med beskrivelse af traumatisering hos mennesker, som har været udsat for 1. linjes traumeeksponering, dvs. direkte eksponering. I Danmark blev diagnosen præsenteret i 1989 (Andersen, Middelboe og Christensen, 1989). Men det er først langt senere i den videnskabelige litteratur, at man er begyndt at kigge på sekundær traumatisering hos mennesker, som har været udsat for 2. linjes traumeeksponering, dvs. indirekte eksponering, herunder, hvordan arbejdet med traumatiserede personer kan have konsekvenser, som rækker udover den traumatiserede selv. Fænomenet er først introduceret i den videnskabelige litteratur i 1990’erne af Lisa McCann og Laurie A. Pearlman (1990) og af Charles R. Figley, (1995). Disse centrale personer har bidraget til en øget opmærksomhed på, at personer, som opnår en tæt relation til et traumatiseret menneske, kan være i risiko for at opleve lignende symptomer som den traumatiserede person. Se kapitlets sidste afsnit for yderligere om forskning i sekundær traumatisering.

Hvem påvirkes?

Erhverv, hvor man dagligt eller regelmæssigt arbejder med traumer, død, lidelse, vold, omsorgssvigt eller trusler, stiller særlige krav til de ansatte og

udsætter dem for en potentiel negativ påvirkning. Det gælder både de ansatte, der arbejder ude på institutionerne eller i behandlingslokalerne og de ansatte, der gennem kontorarbejde og for eksempel journalskrivning også får indblik i lidelsen eller overgrebene. Man kan dele de ansatte ind i 1. og 2. linjehjælpere.

1. linjehjælper er dem, der bliver udsat for en direkte traumeeksponering, da deres arbejde foregår på ulykkes- eller gerningsstedet, i krigszonen eller i et nødhjælpsområde. Ved ulykker er der ofte tale om politi, brandvæsen og ambulancefolk og i krigs- og nødhjælpsområder kan det dreje sig om soldater, læger, sygeplejersker, psykologer og andre nødhjælpsarbejdere. Ansatte på vagtcentraler og andre, der har til opgave at koordinere eller overvåge det akutte arbejde tæller også med i første linje. Mange journalister og fotografer arbejder også i første linje. 1. linjehjælper er på stedet og oplever derfor hændelsen med alle deres sanser, hvilket kan være en stærk påvirkning, både hvad angår lyd, lugt og syn.

2. linjehjælper er dem, der bliver udsat for en indirekte traumeeksponering gennem det efterfølgende samvær med den traumatiserede. De er ikke selv på for eksempel uhelds- eller gerningsstedet, men kan være dem, som første linjen så at sige afleverer til som for eksempel PPR-ansatte. 2. linjehjælper kan igen deles ind i to grupper: Dem, der ansigt til ansigt arbejder med og møder den traumatiserede, og dem, der som administrativt ansatte arbejder med hændelsen gennem journal- eller rapportskrivning.

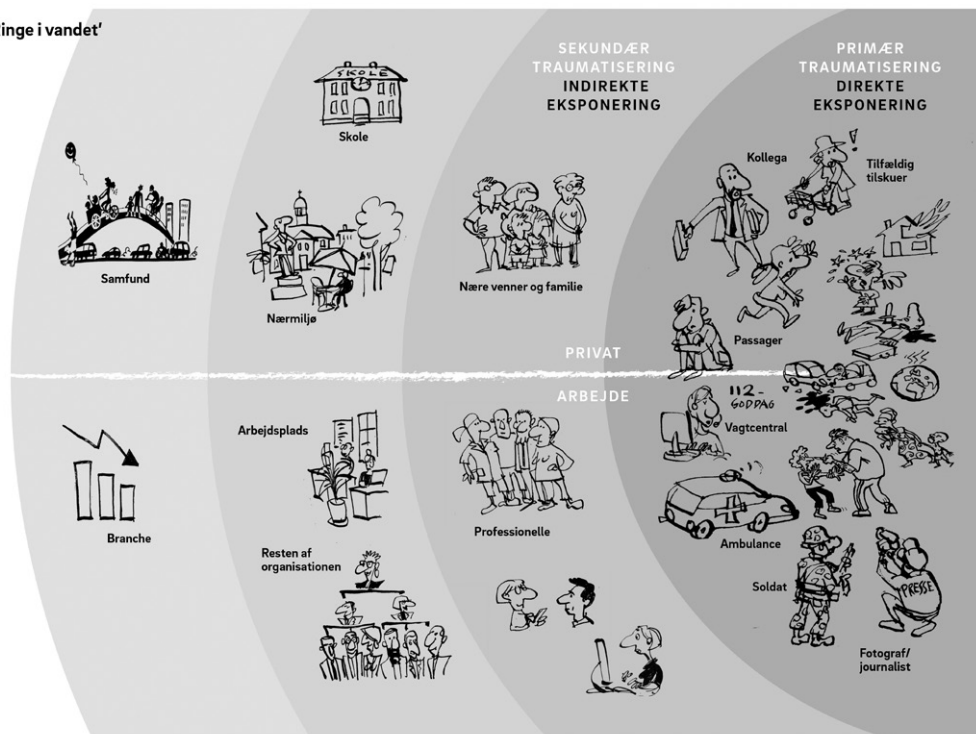
Alle involverede bliver påvirkede på hver deres måde og er i risiko for at udvikle mental slagside, hvis man ikke er opmærksom på det (May & Wisco 2016). Nedenfor ses et uddrag af modellen 'Ringe i vandet', der illustrerer, hvordan kritiske hændelser påvirker forskellige grupper af involverede.

Ringe i vandet

I den inderste cirkel er både selve ofrene for den traumatiske begivenhed, vidnerne – dem, som den tilskadekomne var sammen med, da hændelsen skete eller dem, der tilfældigvis kom forbi og så det ske og endelig de professionelle, der er på stedet for at hjælpe på den ene eller anden måde. Samtlige af disse involverede bliver direkte eksponeret for hændelsen, hvilket kan betyde, at de i dagene efter vil opleve en række større eller mindre efterreaktioner, som for hovedpartens vedkommende vil ophøre igen efter et par dage. Nogle af de udsatte vil imidlertid opleve, at reaktionerne fortsætter og udvikler sig til en primær traumatisering som konsekvens af den direkte eksponering.

Menneskerne i den anden ring i cirklen er dem, der ikke selv har været i direkte fare, men er blevet eksponeret for hændelsen indirekte, idet de enten som den traumatiseredes nærmeste familie eller venner skal *leve med* konsekvenserne af det skete, eller som den traumatiseredes behandlere *skal arbejde med* konsekvenserne af det skete. Begge grupper vil på grund af den tætte kontakt med den traumatiserede person – og for de professionelles vedkommende kontakt med mange traumatiserede personer – kunne blive så

Model 'Ringe i vandet'



Model 'Ringe i vandet', Rikke Høgsted, 2019

påvirkede, at de også selv udvikler et psykologisk traume, som man på grund af den indirekte eksponering kan kalde en sekundær traumatisering.

I modellens tredje ring befinder de øvrige mennesker sig, der i varierende omfang også bliver påvirkede af hændelsen. Det kan være den ramtes klassekammerater, kolleger, naboer og andre i nærmiljøet, ligesom den professionelle øvrige kolleger og hele organisationen vil kunne blive påvirket af situationen. Endelig er der også en fjerde og yderste ring, der illustrerer, at nogle hændelser er så voldsomme eller omsiggribende, at hele samfundet på-

virkes. Det vil kunne dreje sig om terrorhandlinger, naturkatastrofer eller store ulykker, som ændrer produktions- og handelsvilkår for hele brancher.

Hvad er det, der belaster – påvirkningerne

Man vil i almindelighed finde en tæt sammenhæng mellem omfanget af den ydre hændelse og omfanget af den involveredes symptomer. Det vil sige, at menneskerne i første række, de 1. linjeansatte, der befinder sig i centrum for den voldsomme hændelse, statistisk set vil have flere efterreaktioner end dem i anden og tredje række. Der er

tale om et klassisk dosis-respons- eller eksponerings-respons-fænomen. Det vil sige, at risikoen for mental slagside stiger i takt med styrken, omfanget og antallet af voldsomme hændelser, personen er involveret i.

En voldsom hændelse sker imidlertid aldrig i et socialt vakuum. Den sker på et konkret tidspunkt, i en konkret organisation og bliver varetaget af nogle konkrete ansatte. De ansatte håndterer hændelsen på den måde, som den enkelte arbejdsplads har tradition for at gøre det gennem en række personalepolitikker og desuden ud fra arbejdspladsens kultur. Risikoen for at få mental slagside afhænger af selve den ydre hændelses varighed og karakter, organisationens og individets håndtering af hændelsen og endelig en række øvrige forhold, som for eksempel arbejdsfagets status, klager over mulige fejl og mediernes dækning.

Den ydre hændelse

Selve hændelsens karakter vil have betydning. Naturskabte hændelser er for eksempel mindre belastende end menneskeskabte hændelser, ligesom hændelser der involverer voksne udgør en mindre belastning, end hvis ofrene for hændelsen er børn. Også forhold som antallet af implicerede og hvorvidt hændelsen var varslet eller ej har betydning. Hændelser, der er varslede, fordi de sker i et højrisikoområde eller i situationer med klienter/patienter, man godt ved er udadreagerende, er i sig selv mindre psykisk belastende end uforudsigelige og pludseligt opståede hændelser, der måske ydermere sker et ellers normalt trygt og fredeligt

sted. Varslinger giver mulighed for at have de psykologiske parader oppe og være klar til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt i situationen.

Håndteringen af den ydre hændelse

Udover selve hændelsen er der også en lang række organisatoriske forhold, der har betydning for, hvor stor en risiko de ansatte løber. Der er her tale om forhold som f.eks. traumeuddannelse og supervision, kulturen på arbejdspladsen, høj opgavebevidsthed samt klare roller og mandater, arbejdets organisering mm. To forskellige organisationer vil kunne håndtere én og samme hændelse på to ret forskellige måder afhængig af, hvor beredte og hvor bevidste de er på påvirkningen.

Endelig er der også en række individuelle forhold knyttet til både opgaveløsningen og til den ansattes liv i det hele taget, som også har betydning for risikoen for at udvikle mental slagside. Var personen f.eks. aktiv i hændelsen eller tvunget til at forholde sig passivt? Hvordan evaluerer personen selv sin indsats bagefter og hvor i arbejdslivet i øvrigt befinder han eller hun sig – er der tale om en junior eller senior? Her vil personens copingstrategier og øvrige livsvilkår på det pågældende tidspunkt for belastningen også have betydning.

Hvordan kommer belastningerne til udtryk – reaktionerne

Ligesom et skib kan få fysisk slagside, hvis lasten ikke er rigtig balanceret, vil mennesker og grupper få psykisk slagside, hvis det mentalt krævende arbejde ikke er tilrettelagt på en ba-

lanceret og hensigtsmæssig – det vil sige en bæredygtig – måde. Opbygning af modstandskraft og forebyggelse af mental slagside handler overordnet om at tilrettelægge arbejdet på en bæredygtig måde. *Bæredygtighed vil sige, at der er balance mellem udnyttelse og beskyttelse af ressourcerne.* Ressourcer skal her forstås bredt som tid, økonomi og ikke mindst den enkeltes eller teamets faglige og menneskelige kompetencer. En organisation eller person, der blot udnytter ressourcerne uden at have øje for den bæredygtige balance, risikerer mistrivsel, stresssygmeldinger og en stor personaleomsætning. Organisationer og personer, der kun har fokus på at beskytte ressourcerne uden at have øje for den bæredygtige balance, risikerer også mistrivsel, da de ansatte her sandsynligvis vil opleve, at de ikke bliver fagligt udfordret og deres ressourcer ikke anvendt godt nok. Man vil som organisation derudover selvfølgelig også risikere at blive udkonkurreret af andre i branchen, der har fundet en bedre balance.

Fra faresignaler over belastningstilstande til psykiske lidelser

En lang række symptomer eller faresignaler kan være tegn på, at den enkelte ansatte er ved at få eller allerede har fået mental slagside. Faresignalerne kan både komme fra kroppen, fra hovedet, fra følelserne eller fra forholdet til andre. Det kan for eksempel dreje sig om bagatellisering, fornægtelse og kynisme, dissociation eller at man ikke længere ønsker eller orker at tale om sit arbejde.

Opdager man ikke den mentale slagside i tide, vil den kunne blive så stor,

at personen ender med at udvikle en belastningstilstand som for eksempel stress, udbrændthed eller øget forbrug af stimulanser eller en traumatisk betinget psykisk lidelse som tilpasningsreaktion, en posttraumatisk tilstand, angst, depression eller misbrug.

Der findes tilsvarende en række faresignaler om mental slagside i teams og arbejdsgrupper, der har udviklet en form for kollektiv belastningsreaktion – en kollektiv medfølesestræthed: Tab af motivation og en generel mangel på initiativ i gruppen, besvær med at tage såvel store som små beslutninger, lav produktivitet, konflikter og klikedannelse, udpegning af syndebukke, der både kan være et menigt medlem af gruppen eller være lederen, dårligt forhold til samarbejdspartnere og andre, en forrået tone og måske nedladende måde at tale om for eksempel klienterne, borgerne eller kunderne på, øget sygefravær og måske hyppig udskiftning af personale, vrede, brok og utilfredshed og destruktiv humor.

Fagpersoner i mentale højrisikojob er netop personer, altså levende mennesker med hjerteslag, åndedræt og kropsvarme, og vi har ikke blot mulighed for at indleve os i andre menneskers situation, vi kan faktisk slet ikke lade være på grund af vores spejlneuroner. Det menneskelige nervesystem er sådan indrettet, at vi automatisk registrerer andre menneskers følelser og adfærd. 'Opfanger' er måske et bedre ord, for ordet 'registrerer' kan lyde som om, vi er bevidste om det, der sker, og det er ikke tilfældet. Langt de fleste af de informationer om andre mennesker, som vi opfanger, bliver ikke til bevidste tanker, men omsættes straks til



handling, når vi for eksempel går ned ad en travl, befærdet gågade uden at støde ind i andre.

Spejlneuroner og empatisk resonans

Vores evne til at opfange andre menneskers følelser og adfærd sker gennem det, der kaldes spejlneuroner. Spejlneuroner er nogle særlige celler i hjernebarken, der aktiveres og gør det muligt at fremkalde den tilstand hos os, som vi iagttager hos en anden. Man kan sige, at vores nervesystemer automatisk kobler sig på hinanden, svarende til en enhed, der automatisk kobler sig på et wifi, uden der først er givet tilladelse til det. Det er vores spejlneuroner, der også lidt populært sagt kan få følelser til at smitte, og som gennem såkaldt empatisk resonans giver os evnen til at 'læse andre' og indleve os i deres glæder og sorger. Uden vores spejlneuroner kunne vi ikke være empatiske og skabe stærke øjeblikke med andre.

Det giver sig selv, at disse automatiske spejlinger ikke altid kun er af det gode i mentale højrisikjob, hvor det neurobiologiske aftryk fra den, man skal hjælpe, ofte består i intense og smertefulde følelser. Forsiden af spejlneurons mønt er altså, at det gør det muligt for den professionelle at være indlevende og empatisk. Bagsiden er, at det udsætter personen for at blive

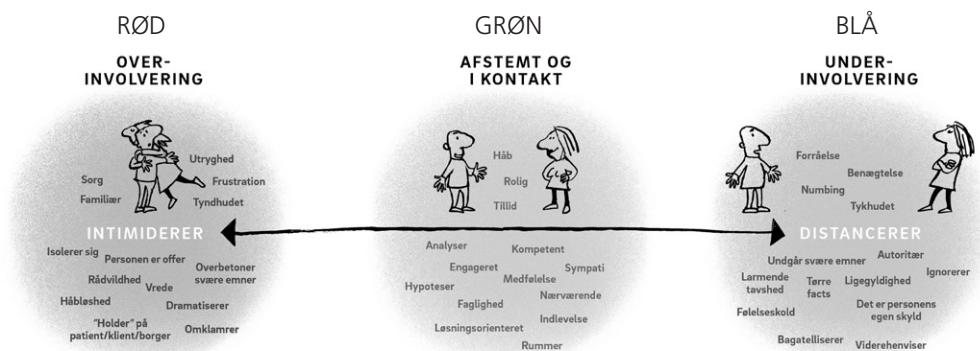
fuldstændig overvældet af smertefulde følelser, som kan kortslutte kontakten til den person, man ellers skal hjælpe, og ødelægge ens evne til at tænke og være løsningsorienteret.

Særligt professionelle, der arbejder med psykoterapi, skal være ekstra bevidste om følelssesmitte og empatisk resonans, idet psykoterapi som behandlingsform bevidst gør brug af terapeutens egne følelser og tanker i behandlingen. Hvor en kræftlæge behandler ved hjælp af operation, kemo- og stråleterapi, kan man sige, at en psykoterapeut behandler ved hjælp af sig selv! Det er her ekstra vigtigt, at man til stadighed er bevidst om at skelne sig selv fra den anden. Gør man ikke det, vil man risikere ved fyraftenstid at være blevet fyldt op med klienternes traumer, sorg, ensomhed, stress, angst og alle de andre følelser, man som psykolog eller psykoterapeut dagligt møder i sin klinik.

Jeg har valgt at bruge begrebet KONTAKT om den position, hvor man som fagperson hverken er over- eller underinvolveret i sit arbejde, men i stedet er tilpas involveret og netop: i kontakt!

AFSTEMT og i KONTAKT og Rød-Grøn-Blå-modellen

Rød-Grøn-Blå-modellen består af tre felter placeret på en vandret linje. Det



'Rød-Grøn-Blå-modellen', Rikke Høgsted

grønne felt i midten af modellen symboliserer der, hvor vi føler os kompetente og fagligt engagerede og hvor vi har oplevelsen af, at vores evner og erfaringer bliver brugt på den gode måde. Vores indsats gør en forskel. Det røde felt til venstre for det grønne symboliserer der, hvor man begynder at overinvolvere sig og det blå der, hvor man modsat begynder at blive underinvolveret. Hvilken side man falder til under pres, vil afhænge af både organisationen, gruppen og personen.

At være AFSTEMT og i KONTAKT

Det grønne felt i midten handler om at være afstemt og i *kontakt*, hvilket vil sige, at man ved hjælp af sin indlevelse er i stand til at lade sig berøre følelsesmæssigt i tillid til, at man på baggrund af sin faglighed, vurderingsevne og resourcer vil kunne påvirke situationen i den rigtige retning. Kontakt kræver, at man kan "mærke sig selv" til trods for den kraftige påvirkning fra personen og/eller situationen. At mærke sig selv vil sige at bevare kontakten med sine kropsfornemmelser og fornemmelsen af, hvem man selv er, og hvad man selv

tænker og føler. Den ansattes evne til kontakt er her helt nødvendig for, at:

1. Personen vil opleve sig respektfuldt og værdigt behandlet, og dermed
2. få tillid til, at man har forstået personen og det, der er sket, og derfor
3. tør, vil eller orker at bidrage med de relevante informationer, så
4. fagpersonen kan lave en faglig analyse af situationen og endelig
5. komme med et forslag til en handlingsplan.

Helt kort: Følelsesmæssig indlevelse er forudsætningen for tillid, der er forudsætningen for data, der er forudsætningen for en faglig analyse og handlingsplan.

At være overinvolveret

Til venstre for det grønne felt findes det røde felt, som handler om overinvolvering. Overinvolvering sker typisk, hvis der opstår en stærk følelsesmæssig identifikation med den, man skal hjælpe. Det betyder, at man er i fare for at blive smittet af den andens følelse af måske hjælpeløshed, frustration, vrede, fortvivlelse og afmagt. Man kan som professionel komme så meget i fø-

lelsernes vold, at man i situationen nærmest helt mister evnen til at tænke og også bagefter har vanskeligt ved det. Overinvolvering vil typisk gøre den professionelle følelsesmæssigt tyndhudet og sårbar, hvilket på et ubevidst eller bevidst plan kan føre til, at patienten/klienten/borgeren er usikker på, om den professionelle holder til at høre om personens smerte eller fortvivelse, frustrationer eller vrede. Overinvolveringen kan også betyde, at den professionelle inviterer til en så fortrolig og personlig relation, at den, der skal hjælpes, føler sig intimideret.

At være underinvolveret

Til højre for det grønne felt findes det blå felt, som modsat handler om underinvolvering. Det er den anden side, man som professionel kan falde til i afmægt, når de svære følelser bliver for voldsomme. Underinvolvering er karakteriseret ved, at den professionelle distancerer sig følelsesmæssigt fra patienten/klienten/borgeren, og i mødet fremstår enten intellektualiserende eller uberørt eller lettere følelseskold, irriteret eller utålmodig. Underinvolvering vil gøre den professionelle følelsesmæssigt tykhudet og måske få vedkommende til at fremstå autoritær og ufølsom. Underinvolvering kan føre til, at den professionelle kommer til at krænke patienten/klienten/borgeren med den nøgterne og kølige facon.

Underinvolvering vil på overfladen hurtigt kunne forveksles med, at personen er i kontrol, hvilket alle professionelle gerne vil være, når de er på arbejde og som i øvrigt generelt også giver status samfundsmæssigt set. Men underinvolveringen er faktisk det stik

modsatte. Den er, ligesom overinvolveringen, udtryk for, at fagpersonen har mistet kontrollen over balancen.

Personalepolitikker

At forebygge mentale arbejdsskader handler om risikohåndtering, hvilket i praksis vil sige at kunne identificere de forhold på ens arbejde, der henholdsvis øger og reducerer risikoen for mental slagside. Det er organisationen, der både juridisk og moralsk har det overordnede ansvar for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. En måde at tage ansvaret på sig er ved at lave gode personalepolitikker, der både kan tiltrække, fastholde og udvikle medarbejderne. En personalepolitik er et dynamisk dokument, som på baggrund af de erfaringer, som organisationen løbende gør sig, regelmæssigt skal revideres. Politikken skal passe til organisationens kultur og indeholde tiltag, der både er rettet mod den stabile hverdag, og dermed forebygger kumulative reaktioner, og tiltag, der er rettet mod de voldsomme hændelser, og dermed forebygger traumatiske efterreaktioner.

Langt de fleste organisationer har allerede personalepolitikker for området med både forebyggende praksisser og faste standardprocedurer for hjælp, hvis skaden alligevel er sket. I mange af disse organisationer anvendes politikkerne dagligt, og de er en integreret del af hverdagen. I andre er politikkerne og procedurerne strandet i en mappe, som ingen rigtig kan huske, hvor er, "men det var i hvert fald nogle gode diskussioner, vi havde, den gang vi lavede dem." Andre organisationer har ikke fået skrevet deres forebyggende

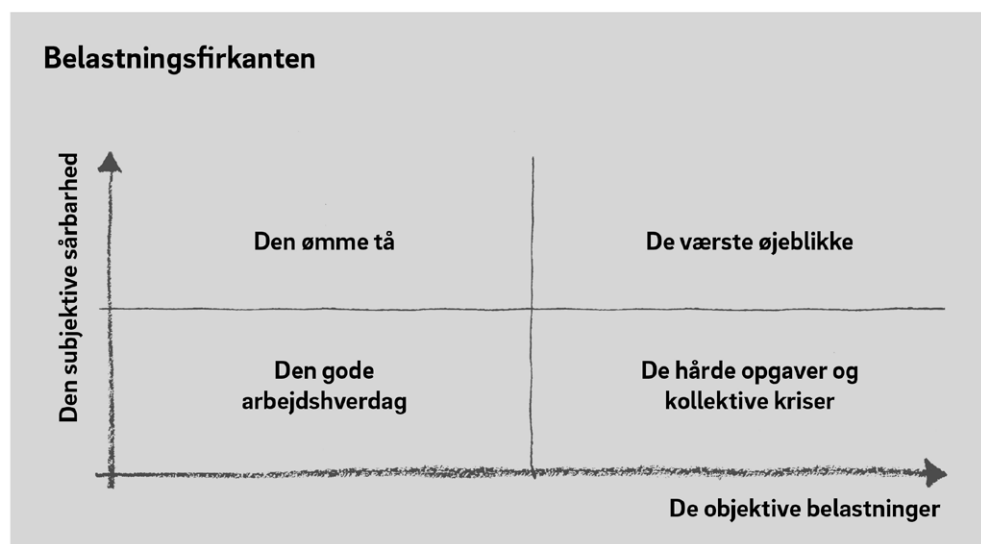
praksisser ned, men har til gengæld en lang række gode traditioner og vaner, der reelt sørger for, at presset bliver jævnt fordelt og de ansatte beskyttet på fineste vis. Og endelig er der de unge organisationer på området, der ikke er kommet så langt i deres proces med at håndtere de mentale risici, da de måske først for nylig har forstået og erkendt, at det er relevant.

Belastningsfirkanten

Belastningsfirkanten består af en x-akse, der afbilder de objektive belastninger og en y-akse, der afbilder den enkelte medarbejders subjektive sårbarhed. X-aksen er bevidst gjort længere end y-aksen, da det er den konkrete ydre hændelse, der udgør den største risiko for, at de ansatte får mental slagside og i værste fald traumatiseres. Belastningsfirkanten er delt ind i fire felter: 1. 'Den gode arbejds-hverdag', 2. 'Den ømme tå', 3. 'De hårde opgaver og kollektive kriser' og 4.

'De værste øjeblikke'. For at opbygge modstandskraft og forebygge skader, skal organisationens personalepolitik indeholde tiltag for samtlige fire felter. De objektive belastninger på x-aksen handler som tidligere nævnt både om hændelsens varighed og hændelsens karakter. Den subjektive sårbarhed på y-aksen handler om den sårbarhed, der knytter sig til henholdsvis fortiden, nu-tiden, identifikation og endelig det at kende dem, man skal hjælpe (p. 125 Høgsted, 2018).

'Den gode arbejds-hverdag' er den, hvor der er overensstemmelse mellem krav og ressourcer og mellem at være effektiv og i stand til at møde patienten/klienten/borgeren omsorgsfuldt og løsningsorienteret. De ansatte vil regelmæssigt blive følelsesmæssigt berørt som en helt almindelig og almen menneskelig reaktion på mødet med kriseramte og traumatiserede mennesker eller i forbindelse med for eksempel verbale angreb og trusler. Mentale



højrisikjob stiller krav til de ansattes evne til at rumme følelser som smerte, fortvivelse, frygt og vrede.

‘Den ømme tå’ er den enkelte ansattes personlige sårbarhed. Sårbarheden kan være knyttet til fortiden eller nutiden, til identifikation eller til, at man kender dem, man skal hjælpe. Nogle ligheder mellem den ansatte og den, der skal hjælpes, er iøjnefaldende, andre usynlige.

‘De hårde opgaver’ handler om de store tragedier, som når en forælder for eksempel slår sine børn ihjel, når en stor ulykke koster mange liv og forårsager store skader, en kollega omkommer i tjenesten eller der er tale om en sag med grov børnemishandling og omsorgssvigt. De hårde opgaver er dem, hvor man som enten 1. eller 2. linje ansat bliver konfronteret med noget så tragisk, grusomt og rædselsvækkende, at man i situationen helt naturligt overvældes af de stærke følelser, som man bagefter skal hjælpe hinanden med at fordøje og sortere i for at kunne genvinde en god kontakt med dem, man skal hjælpe og dermed forblive professionel og løsningsorienteret. En kollektiv krise er en akut opstået hændelse, der involverer og berører store dele af arbejdspladsen, og hvor man skal iværksætte den overordnede beredskabsplan.

‘De værste øjeblikke’ er endelig dem, hvor man som professionel bliver ramt på sin egen sårbarhed, imens man skal løse en særlig hård opgave eller er del af en kollektiv krise. Et værste øjeblik kan være læreren, der for nylig selv har mistet fx en ægtefælle eller søskende på grund af selvmord og som tilfældigvis er ham eller hende, der er

klasselærer for det barn på skolen, hvis storebror eller mor netop har begået selvmord.

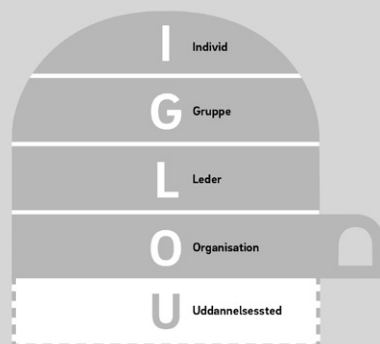
En solid forebyggelsesplan består af velbeskrevne procedurer og retningslinjer for samtlige fire felter som fx traumeuddannelse, supervision, leder-sparring/coaching, mentorordning, psykologisk førstehjælp, psykologisk defusing og debriefing samt en velbeskrevet beredskabs- og kriseledelsesplan (Høgsted, 2018).

Hvad kan man gøre – strategierne

At forebygge mental slagside er en holdsport, der kun lykkes, hvis alle i organisationen – både ledelsen, kollegerne og de enkelte ansatte – forstår deres rolle og ansvar og hver især bidrager aktivt. Det er selvfølgelig organisationen og ledelsen, der har det overordnede juridiske ansvar for arbejdsmiljøet, men det hele begynder som sådan på de uddannelsessteder, der har ansvaret for at klæde de kommende generationer af fagfolk på til at

IGLO-U-modellen

Modellen tydeliggør, at det er en fælles opgave at forebygge mental slagside og skabe trivsel på arbejdspladsen.



varetage et mentalt højrisikjob. Jeg har derfor udvidet den traditionelle IGLO-model med et U og bygget en kælder under den.

Uddannelsesstedernes rolle og ansvar

Studerende skal lige fra begyndelsen af studiet præsenteres for belastningspsykologien. En helt oplagt årsag er selvfølgelig at kvalificere den studerendes valg af fag og give vedkommende en chance for at skifte uddannelse. Det er en ærlig sag, at man ved nærmere eftertanke ikke ønsker at udsætte sig selv for den mentale risiko, der kan være forbundet med arbejdet. En anden vigtig årsag til at uddannelsesstederne skal undervise i belastningspsykologien er, at de studerende på den måde dels kan få mulighed for at modnes langsomt i forhold til at turde tage ansvaret for de mennesker, de bliver uddannet til at hjælpe, og dels lige fra begyndelsen kan lære at passe på med-studerende, kolleger og sig selv. Under studierne får de mulighed for at afprøve forskellige strategier og lære sig selv bedre at kende.

“En af de erfarne lærere på lægestudiet talte om det hvert år og sagde: ‘Nu er der fem år til, at I står med ansvaret for at kunne miste en patient. Nu er der fire år til, at I står med ansvaret for at miste en patient. Nu er der tre år til, ... Det var faktisk rart, for på den måde vænnede man sig til, at det kunne ske’.”

(Høgsted 2018:141).

Endelig er der mange studerende, der i forbindelse med praktikophold eller i studiejob allerede er en del af hverda-

gen på en mental højrisikarbejdsplads. Det gælder for en lang række fag i både sundheds- og socialvæsenet, men også i medieverdenen.

Organisationens rolle og ansvar

En mentalt bæredygtig organisation forpligter sig over for kunder til at forblive professionel i opgaveløsninger og til at levere arbejde på et godt fagligt niveau. Den forpligter sig samtidig over for de ansatte og deres pårørende til at forebygge, at man som ansat tager skade af arbejdet. Det er dermed overordnet set organisationens ansvar at have udviklet og implementeret relevante forebyggende personalepolitikker, så organisationens ledere i hverdagen har nogle rammer at lede i forlængelse af.

Det hele begynder med selve ansættelsen, hvor ansøgeren skal informeres om de mentale risici ved jobbet og om, at man har et fælles ansvar for at forebygge mistrivsel og skader. Det kan være dyrt i kroner og ører, hvis en medarbejder siger hurtigt op igen, og det kan koste dyrebare arbejdsmoral blandt de kolleger, der samvittighedsfuldt har brugt tid på oplæring, kendskab og støtte.

Det er derudover den øverste leders ansvar og rolle at være netop – en god rollemodel – og aktivt tage ansvar for både sin egen og de øvrige ledes trivsel. Både trivsel og mistrivsel smitter og en stresset, frustreret eller utilfreds ledergruppe vil før eller siden resultere i generel mistrivsel i hele organisationen (Skakon 2010). Det er yderligere den øverste leders ansvar at sikre den fysiske sikkerhed og ansættelsesvilkår, der tilstræber at imødekomme de an-

sattes eventuelle ønsker og behov i forhold til nedsat tid, orlov eller seniorordning. Mange fagpersoner bliver i disse år længere tid på arbejdsmarkedet, hvilket kalder på en ledelsesmæssig bevidsthed for at forebygge kumulative belastningsreaktioner.

Endelig er det organisationens opgave at skabe en lærende kultur generelt og i særdeleshed i forhold til de fejl, som medarbejderen fra tid til anden vil begå. Fokus skal her være på organisationens ansvar, og hvad hele organisationen – og måske branchen – kan lære af hændelsen frem for et fokus på individniveau.

“I Forsvaret talte vi om ‘Lesson Identified’ og ‘Lesson Learned’. Det var faste begreber, som havde eksisteret længe før jeg blev ansat, og det havde en beroligende virkning på mig. Det var sådan ligesom, “jamen så har der jo været generationer før mig, der heller ikke altid løste opgaven til UG med kryds og slange.” Det var et stærkt signal om, at vi ikke bare kan blive bedre, men også forpligter os til det fagligt.”

(Høgsted 2018:148).

Lederens rolle og ansvar

At være leder på en arbejdsplads med mental højrisiko kan være noget af en balancegang. Arbejdet med fx traumer, overgreb, vold og omsorgssvigt kalder på en tydelig og omsorgsfuld leder, der kan skabe klare rammer og foretage tydelige prioriteringer i al det tragiske eller provokerende. Samtidig vil medarbejdere have brug for luft og rum omkring sig til at fordøje og bearbejde de stærke indtryk. De ansatte løfter på

et stort ansvar for andre mennesker. De stiller sig selv til rådighed og bruger deres indlevelsessevne for at opnå den andens tillid, så de kan lave en god faglig analyse og handlingsplan. De har derfor, om nogen, brug for at blive mødt med tillid og overladt et ansvar. Opskriften på, hvordan man dels sætter klare rammer for arbejdet og samtidig møder den ansatte med tillid og giver ansvar, kan opleves som et paradoks, men er i bund og grund det, som meget ledelse handler om.

Lederens rolle og ansvar handler blandt andet om rekruttering. Det siger sig selv, at det er vigtigt at ansætte folk med de rette kompetencer. Men dette forhold bliver ekstra vigtigt i job, hvor fejl og usikkerhed fra den ansattes side kan få fatale konsekvenser for den, man skal hjælpe. Derudover vil et gab mellem de krav, der stilles til de ansatte og hans eller hendes faglige- og menneskelige kompetence, udgøre en risiko for mistrivsel og mental slagside.

En helt central del af lederens ansvar handler om høj opgavebevidsthed og om at skabe klare roller i arbejdsgruppen. Når en opgave er velbeskrevet, og der både hersker klarhed over ansvar og beslutningskompetence og over rammerne, inden for hvilken opgaven skal løses, er det muligt for den enkelte medarbejder eller for arbejdsgruppen at lægge en god plan for arbejdet og have realistiske faglige forventninger til sig selv.

Det er også lederens ansvar at sørge for et professionelt sprogbrug. Et arbejde med regelmæssige mentale belastninger, og derfor fare for henholdsvis over- eller underinvolvering, kan udvikle et uprofessionelt sprogbrug.

Det er faktisk nogle gange gennem sproget, at man bliver opmærksom på slagsiden. Overinvolvering kan for eksempel komme til udtryk igennem en ængstelig eller irriteret tone, dramatiske eller meget kærlige vendinger eller gennem hyppig brug af familiære udtryk. Underinvolvering kan modsat rent sprogligt resultere i en afmålt eller kølig tone, fordømmende vendinger eller igennem et meget formelt og tørt sprog.

Endelig har lederen også det overordnede ansvar at få fordelt opgaverne på en måde, så gruppens samlede ressourcer bliver brugt bedst muligt. Hvordan lederen vælger at udmønte det ansvar, vil være forskelligt fra virksomhed til virksomhed. På nogle arbejdspladser er man vant til, og måske også tilfreds med, at det primært er lederen, der fordeler opgaverne. På andre arbejdspladser er der tradition for, at det er teamet, der sammen med lederen foretager fordelingen af opgaverne. Uanset, om man har tradition for at gøre det på den ene eller anden måde, er der en række principper, man skal holde sig for øje, som har direkte betydning for, hvor påvirket man risikerer at blive af arbejdet. Det drejer sig blandt andet om: princippet om, at de sværeste opgaver per definition er teamets; princippet om variation; princippet om bevidst opgavedeling og princippet om at bruge den bedste del af arbejdstiden på de sværeste opgaver.

Ligesom toplederen skal lederen selvfølgelig også tage både sin egen og gruppens trivsel alvorlig og selvom evt. mistrovsel kan skyldes mange ting, og slet ikke behøver at have noget med

traumatisering og følelsesmæssige høje krav at gøre, skal man alligevel altid tage det med i betragtning. Det udgør den klangbund i jobbet, som alle de øvrige forhold står på.

Gruppens rolle og ansvar – social støtte

At opbygge modstandskraft og forebygge traumatisering foregår, som nævnt, på alle niveauer. Man har som gruppe og kolleger ansvar for hinanden. Der er hverken tale om et juridisk eller fagligt ansvar, for det er selvfølgelig gruppens leder, der formelt har ansvaret. Der er her snarere tale om et kollegialt og medmenneskeligt ansvar både for den enkelte og for gruppen. At være en del af en velfungerende arbejdsgruppe er noget af det mest forebyggende, der findes i forhold til at håndtere psykiske belastninger og undgå mental slagside.

Man kan som gruppe yde hinanden social støtte på flere måder gennem følelsesmæssig støtte, feedbackorienteret støtte, rådgivende eller faglig støtte og endelig gennem praktisk støtte.

Følelsesmæssig støtte

Kolleger kan støtte hinanden på en måde, som ingen andre kan, om end man gerne vil. At være sammen med mennesker, der fra deres eget liv ved, hvad man taler om, vækker en dyb genklang og ophæver den ensomhed, der ellers ofte knytter sig til oplevelserne på arbejdet. Se evt. metoden *Fiskerbænken* sidst i kapitlet.

“En af de stærkeste oplevelser af fællesskab, jeg nærmest har haft som menneske, handler faktisk om

arbejdet. Jeg havde som journalist været ude for at dække en forfærdelig busulykke med mange omkomne, heraf flere af dem var børn og unge. Mange af passagererne var blevet mast helt sammen og var svære for redningsmandskabet at skære fri. Det havde været en lang aften og nat, ude på en mark og hundekoldt, og jeg sad nu i den tidlige morgen-time på vejen hjem i min bil nærmest lammet af de mange indtryk fra ulykkesstedet. Så tikkede der pludselig en sms ind på mobilen fra en ældre kollega, hvor der stod noget i retning af: "Jeg har lige hørt om ulykken og tænker på, hvordan du har det? Jeg har en gang også prøvet sådan en ulykke og syntes, det var vanvittig hårdt. Ring, hvis du vil." Jeg tror aldrig, jeg har følt mig så forstået før i hele mit liv."

(Høgsted 2018:158).

Voldsomme hændelser på jobbet knytter kolleger sammen, og det er godt. Man skal imidlertid være opmærksom på, at tilknytningen ikke bliver ensbetydende med, at man isolerer sig fra andre – professionelt som privat. Nok vil andre, der ikke har haft tilsvarende oplevelser, ikke kunne forstå og spejle en på samme måde som kollegerne, der har, men de vil til gengæld kunne tilbyde en andre former for omsorg og støtte.

Den følelsesmæssige støtte kan også finde sin vej gennem en række principper som fx princippet om at dele, princippet om sort humor eller princippet om ikke at overdosere hinanden. Man kan også vælge at indføre en defusing-vagtordning, som i korte træk går ud

på som kolleger på skift og planlagt at stiller sig til rådighed for kolleger, der ved arbejdsdagens slutning har behov for at få bevidnet oplevelser, der har gjort et særligt indtryk. (Høgsted 2018: 167).

Feedbackorienteret støtte

At tilhøre en gruppe er generelt en beskyttende faktor. Der kan imidlertid også være en bagside ved at være en del af en gruppe. Bagsiden handler om de mere destruktive – men desværre helt almindelige – gruppeprocesser som for eksempel mobning, udpegning af synderbukke eller gruppetænkning. Gruppetænkning er, når gruppemedlemmer undertrykker deres egne personlige og faglige værdier eller ideer og sætter social accept og gruppeharmonihøjere end værdierne. Det kan betyde, at man ikke får reageret på en adfærd, man ellers finder uacceptabel og specielt ikke, hvis der er tale om, at det er gruppens formelle eller uformelle ledere, der har/udøver den uacceptable adfærd.

Man kan undre sig over, at dygtige fagfolk ikke får sagt fra overfor fagligt uacceptabel adfærd. Forklaringen er formentlig, at ønsket om at tilhøre gruppen – og opnå og fastholde gruppens accept – nogle gange kan være stærkere end ubehaget ved at bevidne den uacceptable adfærd. Man vil efter en tid måske heller ikke rigtig mærke ubehaget længere. Det kan skyldes fornemmelsen af, at gruppen er hævet over al kritik, nu hvor den løser så barsk en opgave. Det kan også skyldes, at man slet og ret har vænnet sig så meget til adfærden, at man ikke længere registrerer den. Der sker også tit

det, at man for at bevare sit medlemskab af gruppen udvikler forskellige former for selvbedrag i form af undskyldninger for adfærden og forklaringer, der handler om årsagsforhold, der ligger uden for gruppens indflydelse (Birkemose 2016).

Ens kolleger er imidlertid ofte dem, man reelt bruger mest tid med i hverdagen. Det er derfor også dem, der har fingeren bedst på pulsen i forhold til, hvordan man løser sine opgaver og dermed bedst kan give hinanden en fremadrettet, konstruktiv og ærlig feedback.

Rådgivende og faglig støtte

Rådgivende og faglig støtte handler bredest set om at dele sin viden med hinanden. Videndeling kan ske gennem intern undervisning, måske efter at en kollega har været på et kursus, eller gennem for eksempel konferencer, møder eller supervision. Regelmæssige faglige drøftelser, måske ekstraordinært indkaldt, både før, under og efter en psykisk krævende opgave, kan være utrolig værdifuld for de kolleger, der står midt i opgaven og skal navigere i et måske følelsesmæssigt kaos.

Faglig støtte kan også gives ved konkret at løse opgaver sammen. Også selv om det måske ikke er strengt nødvendigt, men fordi det kan være en måde at udveksle tavs viden på. Tavs viden er den viden, som overføres fra en person til en anden, når en person i praksis viser en anden person, hvordan en opgave kan udføres og håndteres. Mennesker er ofte ikke bevidste om den tavse viden, de besidder, og hvor værdifuld den kan være for andre.

Praktisk støtte

Praktisk nu-og-her-hjælp med opgaverne er tit den bedste måde at støtte kollegaen på. Medlemmerne af en gruppe vil, lige som alle andre mennesker, på skift være ovenpå og i knæ. Skilsmisser, demente forældre, sygdom, trusler på jobbet eller voldsomme hændelser er en del af livet for den ansatte, som ind imellem vil trække ekstra på kræfterne og betyde, at man ikke har tid og mulighed for at yde samme indsats, som man plejer. Der kan også være tale om, at nogle i gruppen i en periode har ekstra travlt, fordi der tilfældigvis er landet ekstra mange opgaver på deres bord, hvilket ikke var til at forudsige og dermed planlægge sig ud af.

“Jeg er så træt af vendinger som: ‘Pas nu godt på dig selv’. Hvis man er presset tænker man bare ‘Ja tak, men hvordan?’. Jeg har lovet mig selv ikke at sige det igen til hverken en ansat eller kollega men i stedet spørge: ‘Er der noget jeg kan hjælpe dig med?’.” (Høgsted 2018:173).

Individets rolle og ansvar

Mange af symptomerne på mental slagside bor så at sige på indersiden og er usynlige, hvilket gør det sværere for andre at opdage, end hvis der var tale om fysiske symptomer som fx udslæt, hoste eller at man er begyndt at trække på benet. Det er kun én selv, der for alvor ved, hvordan det står til inden i, hvilket endda kan være svært at mærke på grund af psykologiske blinde vinkler og vores hjerners begrænsede kapacitet til at bevidstgøre alle de sansindtryk, vi konstant modtager fra vo-

res krop og verdenen omkring os. Det er derfor individets vigtigste rolle og ansvar at være i kontakt med sig selv og melde ud, hvis den indre båd begynder at vippe og få slagside.

Der findes en lang række velbeskrevne selvhjælpsstrategier i de efterhånden mange gode bøger, hjemmesider og podcast, der findes på markedet og det falder uden for denne artikels rammer at beskrive dem nærmere. Man kan i "Grundbog i belastningspsykologi" læse om en lang række af principper for selvhjælp præsenteret gennem modellen "Den strategiske diamant", der opererer med strategier for henholdsvis tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Samtlige strategier falder inden for rammen af den ansattes arbejde, da det jo er her, at belastningerne opstår og skal håndteres. Det betyder ikke, at man ikke også kan lave en række aktiviteter i fritiden, men det bør ikke være nødvendigt for at opretholde et bæredygtigt arbejdsliv.

Et eksempel på en af de mange strategier er princippet *Du er ikke alene*, der er rettet mod tankerne og det at bryde den isolation, man kan opleve, hvis man i situationen er alene om at bevidne de forfærdelige forhold. Man kan da gennem sin tænkning forsøge at forbinde sig til et større fællesskab af fagfæller, der har taget samme opgave og sag på sig og tænke noget i retning af "Der findes andre fagfolk som mig, der i dette selv samme øjeblik sidder over for et menneske, der er blevet voldtaget, har mistet sit barn eller er uhelbredelig syg". En af strategierne, der er rettet mod følelserne er princippet om at føle *med* og ikke føle *som*.

Det er misforstået omsorg at tro, at god hjælp er lig med at sætte sig i den andens sted. At sætte sig i en mors sted, der netop har mistet sit barn, ved at forestille sig, at man også selv lige har mistet sit barn, vil ende med to fuldstændig ulykkelige mennesker. En klog kollega citerede engang en anden klog kollega for at have sagt: "Det handler om at tænke: Ja, det kunne have været mig. Men det er det ikke!" Princippet om at føle med og ikke som, handler om at kunne rumme og genkende følelser uden selv at føle dem.

Et eksempel på en strategi rettet mod kroppen er princippet om at mærke sig selv. At skærpe bevidstheden om at alt det, der er inden under ens hud, er én selv, og alt det, der er udenfor, er resten af verden. Den lidt sjove sætning handler om det centrale forhold, at man som ansat i et mentalt højrisikjob er i risiko for at blive smittet af den ydre hændelses rædsel, smerte og måske lige frem gru. Vores hud er kroppens største organ, og den er helt konkret grænsen mellem os selv og andre. At mærke sin krop og sin hud er en effektiv måde at huske sig selv på, at den rædsel og smerte, man i øjeblikket bevidner, ikke tilhører en selv, men den eller de andre. Der findes en lang række metoder til at mærke sig selv og forblive adskilt (Isdal 2018 og Høgsted 2018), så mødet kan blive et stærkt møde mellem et menneske, der har brug for hjælp og et menneske, der gerne vil hjælpe.

Endelig er der strategier rettet mod adfærden som eksempelvis det vigtige princip om at undgå selvskabt overdosering og være sig bevidst om, hvornår og hvorfor man spørger ind til detaljer

i en voldsom eller smertefuld sag. Er det fagligt relevant at vide alle detaljer? Når det kommer til mental slagside, er der tale om en dosisresponsammenhæng. Jo flere og jo kraftigere påvirkninger, jo større reaktion. Følelsen af pligt eller behovet for at demonstrere styrke er klassiske årsager til, at man som professionel i et mentalt højrisikjob risikerer at tage en "overdosis". Nogle hjælpere oplever, at det som føles som en form for moralsk opgave og nødvendighed i forhold til ønsket om at vise ofrene respekt på. At de er forpligtede til at spørge detaljeret ind til detaljerne i beretningen om overgrebene eller kigge samtlige fotos fra et ulykkes- eller gerningssted igennem, selvom man har fundet et, man kan bruge til reportagen.

Når man regelmæssigt bliver eksponeret for andres traumer, vil man også regelmæssigt komme i kontakt med sin egen sårbarhed. Man kan som modvægt til sårbarheden have behov for at mærke sin egen styrke og for at bevise overfor både sig selv, kollegerne og måske lederen, at man også er stærk. Dette behov kan betyde, at man fristes til at spørge til detaljer eller se på fotografier og videoer, der ikke er fagligt nødvendige. Hvis der er tale om en terrorhandling, hvor en gerningsmand slår et gidsel ihjel for rullende kamera, kan ens foragt for handlingen betyde, at man føler behov for at bevise, at man ikke vil lade sig skræmme og derfor godt "tør" se det. Man skal da huske på, at ved at se videoen gør man præcis, hvad morderne vil have en til at gøre, og meget stærke billeder glemmer man sjældent igen. De vil ligge i ens hukommelse og kunne være dråber

i et bæger, der en dag risikerer at løbe over og være medvirkende til at give mental slagside.

Princippet om at undgå selvskabt overdosering handler om at holde hovedet koldt og hjertet varmt og huske på, at man faktisk reelt forringer sin evne til at hjælpe den anden, hvis man selv bliver for overvældet af gruen eller smerten. At kunne berolige sig selv er en nødvendig forudsætning for at arbejde i et mentalt højrisikjob og i øvrigt noget selv for tidlig fødte børn evner, når de i kuvøsen for eksempel holder fast i en sonde eller stemmer ryggen mod kuvøsens væg for at berolige sig selv.

Forskning i sekundær traumatisering

Forskningsfeltet omkring fænomenet sekundær traumatisering er i spirende udvikling, men lider under nogle forskningsmæssige udfordringer. En grundlæggende udfordring er, at der historisk set er blevet anvendt flere begreber til at beskrive reaktionerne på 2. linjes traumeeksponering hos fagpersoner. Det er blevet kaldt for vikarierende traumatisering (McCann & Pearlman, 1990; Pearlman & Saakvitne, 1995), sekundær traumatisk stress (Figley, 1995), sekundær traumatisk stress-forstyrrelse (Figley, 1995), medfølestræthed (Figley, 1995) og medfølelsesstress (Figley, 1995). Et fælles træk for disse begreber er, at de peger på en sammensætning af responser på klienttraumer, der ligner PTSD-symptomer (Figley, 1995; Pearlman & Saakvitne, 1995).

Anvendelse af forskellige begreber for sekundær traumatisering kommer

også til udtryk i anvendelse af mange forskellige måleinstrumenter til at indfange fænomenet. Nogle studier anvender måleinstrumenter, som er specifikt udviklet til at måle symptomer på 2. linjes traumeeksponering; Secondary Traumatic Stress Scale (Bride et al., 2004), Compassion fatigue self-test (Figley, 1995; Figley & Stamm, 1996) og Professional Quality of Life Scale (Stamm, 2003; 2005; 2010). Andre studier anvender måleinstrumenter, som oprindeligt er udviklet til at måle PTSD-symptomer og andre traumereaktioner på 1. linjes traumeeksponeringer. Når måleinstrumenter ikke er specifikt konstrueret til at måle sekundær traumatisering, er det vigtigt, at forudgående instruktioner er tydelige om, at fagpersonen skal besvare spørgsmålene i relation til sin beskæftigelse. I forlængelse heraf er der uenighed på forskningsfeltet om hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at tale om sekundær traumatisering. Derfor kan der være stor forskel på studier med hensyn til, hvor længe og i hvilken sværhedsgrad symptomerne skal være til stede, før tilstanden anerkendes som sekundær traumatisering. Endelig udfordres feltet også af, at størstedelen af studierne omkring sekundær traumatisering på nuværende tidspunkt er tværsnitsundersøgelser og at de ikke har medtaget kontrolgrupper. Det er derfor uvist, om resultaterne specifikt er relateret til fagpersoner, som arbejder med traumatiserede, eller om de skal tillægges andre forhold vedrørende de medarbejdere og arbejdspladser, som indgår i studierne.

Måske vil fremtiden vise, at det ikke er nødvendigt at måle sekundær tra-

omatisering adskilt fra PTSD. For med den nyeste udgave af det amerikanske diagnosesystem, DSM-5, er det blevet anerkendt, at det er muligt at blive sekundært traumatiseret gennem sit professionelle erhverv. De seneste ændringer for PTSD har her nemlig gjort det eksplicit, at gentagen eller ekstrem eksponering for ubehagelige detaljer af en traumatisk begivenhed – gennem ens professionelle virke – også er kvalificeret som kriteriet traumeeksponering (American Psychiatric Association, 2013). Dette gælder dog ikke for eksponering for elektroniske medier, tv, film eller billeder, medmindre det er arbejdsrelateret (American Psychiatric Association, 2013). Dette kriterie er netop tiltænkt fagpersoner, som aldrig selv har været i direkte fare, men som erfarer konsekvenserne af traumatiske begivenheder i deres daglige arbejde (Friedman, 2013). Det betyder, at sekundær traumatisering i svære tilfælde kan anses som en form for PTSD (Hensel, Ruiz, Finney, Dewa, 2015).

Afrunding

Jeg har som krisepsykolog gennem årene haft samtaler med en lang række professionelle fra forskellige mentale højrisikojob. Samtalerne har handlet om belastende påvirkninger på arbejdet, der naturligt nok – og heldigvis – har gjort særlig indtryk på de ansatte. Når jeg skriver heldigvis, er det fordi, kun døde ting som robotter ikke lader sig påvirke af voldsomme eller tragiske hændelser. Det gør vi mennesker, og det skal vi gøre for at forblive psykologisk i live og kunne udføre et godt stykke arbejde. Det er på ingen måde

en skam at lade sig følelsesmæssigt påvirke, når man på arbejdet igen og igen konfronteres med voldsomme eller tragiske forhold. Tværtimod. Alternativet er at stivne i en pansret udgave af sig selv uden kontakt til sine egne og andres følelser.

Alle professionelle vil til tider trække til den ene side og blive tykhudet og til andre tider trække til den anden side og blive tyndhudet. Det er fuldstændig menneskeligt. Kunsten er gang på gang at få øje på det og at komme ind på midten af vejen igen. Mine mange års erfaring har imidlertid lært mig én ting: Man kan kun holde til et psykisk krævende job i længden, hvis de andre på arbejdspladsen er med på den og tager et medansvar. At forebygge mentale skader er en holdsport – *It takes a whole organisation to prevent a trauma*. Traumeeksponering kan påvirke alle i organisationen, hvilket både i hverdagen og under pres vil kunne forringe alles evne til at tænke og handle klart og professionelt. Løsningen er en kollektiv bevidsthed om fænomenet og erkendelse af at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, der kunne lykkes, hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar.

Fiskerbænken

En fødselslæge fortalte mig en dag: *“Vi er hos os ret gode til alt det med defusing og debriefing. Men vi er måske ikke så gode til at give os selv lov til bare at være i den fase, hvor man er træt og ked af det.”* (Høgsted 2018:161). Kommentaren inspirerede mig til en metode, jeg har valgt at kalde Fiskerbænken, inspireret af Danmarks lange

tradition for fiskeri, der i forhold til den fysiske sikkerhed må betragtes som et risikoerhverv. Utallige fiskere er gennem historien omkommet på havet og har gjort mange kvinder til enker og store børneflokke faderløse.

Mange læsere kan for deres indreblik formentlig fremkalde et motiv bestående af en lille gruppe fiskere sidende på en bænk op ad et fiskerskur. Stille, tænksomme og nu i sikkerhed. Fangsten er landet, fiskenettene røgtet. Tid til at fordøje tanker og indtryk med hinanden inden næste tur ud på havet.

Man kan som gruppe have glæde af en stund, hvor man mødes på Fiskerbænken og deler det, der har gjort indtryk. Ikke for at reflektere, diskutere eller debattere faglige tvivlsspørgsmål og dilemmaer. Formålet med at mødes på Fiskerbænken er alene at dele de stærke indtryk fra arbejdet og bare *være med det* for en stund.

“Man er jo fuld af gode actionhistorier fra arbejdet, så man risikerer nogle gange at skøjte henover alle følelserne, hvis man ikke lige sætter tempoet ned en gang imellem og stopper op.” (Høgsted 2018:160).

Fiskerbænken er et supplement til supervision eller anden form for faglig vejledning og kan ikke erstatte disse fora. Man kan aftale at mødes på Fiskerbænken fast en gang om ugen eller måneden eller efter behov. Fiskerbænken er tænkt som en stille kollektiv væren med det svære, det triste, det forfærdelige og det hårde ved jobbet. Det handler ikke om at prøve at fjerne det, men om at dele det med hinanden.

Man kan også bruge Fiskerbænken til at dele tidligere hårde opgaver. Nogle opgaver gør bare et særligt indtryk på en.

“Nogle sager sidder bare i kroppen og kommer ind imellem tilbage. Så får man det sådan ‘Åh nej – det var så forfærdeligt’. Efter lidt tid klinger det af igen og en dag kommer det så rullende tilbage. Det går lige som i bølger. I begyndelsen var det forbundet med tanker om, hvorvidt jeg havde gjort det rigtige. Var det for eksempel rigtigt af mig, at jeg havde taget en helt ung psykolog med ind i rummet. Om det havde været for hårdt for hende og sådan. Nu er det mere bare en erindring om noget forfærdelig sørgeligt.”

(Høgsted 2018:1612).

At mødes på Fiskerbænken

Find et roligt sted enten indenfor eller udenfor, hvor I kan sidde på en bänk eller på en række stole, der står ved siden af hinanden. Vælg et sted med udsigt, hvis det er muligt, så øjnene kan vandre lidt. Sørg for at I ser i samme retning. Øjenkontakt er fint, når man er i dialog, men kan virke forstyrrende, når man ønsker at se indad. Begynd med et par dybe vejrtrækninger. Rolige kroppe smitter, helt ligesom urolige og anspændte kroppe gør. Når roen er faldet på jer, begynder den første på bænken at fortælle om en oplevelse, han eller hun har haft siden sidst, som har gjort indtryk. Nogle fortællinger er korte, andre lange. Gruppens opga-

ve er at lytte aktivt. Det vil sige ikke bare høre efter men lytte for at blive klogere på, hvad kollegaen fortæller. Når fortællingen er slut, skal fortælleren takke gruppen for, at de lyttede og gruppen takke personen for at dele sine oplevelser med gruppen. Det er vigtigt, at man får sluttet hver fortælling af og sat punktum med de to gange “tak” inden næste fortælling. Det er en god måde at ære det sagte og at undgå at blande fortællingerne sammen.

Når den første person på bænken har talt, går ordet videre til den næste. Hvis han eller hun ikke har noget på hjerte, siger vedkommande bare “pas” og giver ordet videre. Man har ikke ‘talepligt’ på en fiskerbänk – kun tavshedspligt. Aftal inden start, hvor lang tid ugens eller månedens Fiskerbänk skal vare. Aftal også, hvem der er dagens ‘skipper’ der holder øje med tiden og siger til, når gruppen skal til at slutte af.

Referencer

- Akinsulure-Smith, A. M., Keatley, E., & Rasmussen, A. (2012). Responding to Secondary Traumatic Stress: A Pilot Study of Torture Treatment Programs in the United States. *Journal of Traumatic Stress*, 25, 232–235.
- American Psychiatric Association. (1980). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 3rd edition. Washington, D.C.: American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5th Edition. Washington, D.C.: American Psychiatric Association
- Andersen, H.S., Middelboe, T., Christensen, A.K. (1989). Posttraumatic stress disorder I. Baggrund. *Ugeskrift for Læger*, 151, 2242-5.

- Andersen, H.S., Christensen, A.K., Middelboe, T. (1989) Posttraumatic stress disorder II. Behandling og kliniske eksempler. *Ugeskrift for Læger*, 151, 2245-7.
- Backholm, K. & Idås, T. (2015.). Ethical Dilemmas, Work-Related Guilt, and Posttraumatic Stress Reactions of News Journalists Covering the Terror Attack in Norway in 2011. *Journal of Traumatic Stress*, 28, 142–148.
- Birkmose, D. (2016). Når gode mennesker handler ondt. Tabuet om forræelse. Syd-dansk Universitetsforlag. Odense.
- Brewin, C. R., Andrews, B., & Valentine, J. D. (2000). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. *Journal of consulting and clinical Psychology*, 68 (5), 748-766.
- Bride, B. E., Robinson, M. M., Yegidis, B., & Figley, C. R. (2004). Development and validation of the Secondary Traumatic Stress Scale. *Research on Social Work Practice*, 14, 27–35.
- Conrad, D. & Kellar-Guenther, Y. (2006). Compassion fatigue, burnout, and compassion satisfaction among Colorado child protection workers. *Child Abuse & Neglect*, 30, 1071-1080.
- Falk, B. (1998). Kærlighedens pris. Forlaget Anis. Frederiksberg.
- Friedman, M. J. (2013). Finalizing PTSD in DSM-5: Getting Here From There and Where to go Next. *Journal of Traumatic Stress*, 26, 548-556.
- Figley, C.R. (1995). *Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatised*. New York: Brunner/Mazel.
- Figley, C. R. & Stamm, B. H. (1996). Psychometric review of Compassion Fatigue Self Test. In B. H. Stamm (Ed.), *Measurement of stress, trauma, and adaptation* (pp. 127–130). Lutherville, MD: Sidran Press.
- Gil, S. & Weinberg, M. (2015). Secondary trauma among social workers treating trauma clients: The role of coping strategies and internal resources. *International Social Work*, 58 (4), 551-561.
- Hensel, J. M., Ruiz, C., Finney, C., Dewa, C. S. (2015). Meta-Analysis of Risk Factors for Secondary Traumatic Stress in Therapeutic Work With Trauma Victims. *Journal of Traumatic Stress*, 28, 83-91.
- Høgsted, R. (2018). *Grundbog I belastnings-psykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende job*. Forlaget Ictus. København.
- Høgsted, R. (2019). *Grundbog I belastnings-psykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende job*. 2. reviderende udgave. Forlaget Ictus. København.
- Høgsted, R. & Petersen, A.S.M. (1999). Når sjælen rystes. Danmarks Forvaltningshøjskole. Frederiksberg.
- Isdal, P. (2018). Medfølelsens pris. Akademisk Forlag. København.
- Jones, N., Seddon, R., Fear, N.T., McAllister, P., Wessely, S., & Greenberg N (2012). Leadership, Cohesion, Morale, and the Mental Health of UK Armed Forces in Afghanistan. *Psychiatry* 75(1).
- Knudsen, L., Berliner, P. & Høgsted, R. (1998). Psykisk førstehjælp og medmenneskelig støtte, Dansk Røde Kors, København.
- Kulkarni, S., Bell, H., Hartman, J.L., & Herman-Smith, R.L. (2013). Exploring Individual and Organizational Factors Contributing to Compassion Satisfaction, Secondary Traumatic Stress, and Burnout in Domestic Violence Service Providers. *Journal of the Society for Social Work and Research*, 4(2), 114-130.
- May, C. L. & Wisco, B. E. (2016). Defining Trauma: How Level of Exposure and Proximity Affect Risk for Posttraumatic Stress Disorder. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy*, 8(2), 233-240.
- McCann, L & Pearlman, L. A. (1990). Vicarious Traumatization: A Framework for Understanding the Psychological Effects of Working with Victims. *Journal of Traumatic Stress*, 3(1), 131-149
- Nelson-Gardell, D., & Harris, D. (2003). Childhood Abuse History, Secondary Traumatic Stress, and Child Welfare Workers. *Child Welfare League of America*. Vol. LXXXII, #1.
- Pearlman, L.A. & Saakvitne, K.W. (1995). *Trauma and the therapist: Countertransference and vicarious traumatization in psychotherapy with incest survivors*. New York: W.W. Norton.
- Peled-Avram, M. (2017). The Role of Relational-Oriented Supervision and Personal and Work-Related Factors in the Development of Vicarious Traumatization. *Clinical Social Work Journal* 45, 22–32.
- Rona R.J., Hooper, R., Jones, M., Iversen, A.C, Hull, L., Murphy, D., Hotopf, M. & Wessely, S. (2009). The Contribution of Prior Psycho-

- logical Symptoms and Combat Exposure to Post Iraq Deployment Mental Health in the UK Military. *Journal of Traumatic Stress*, 22, 1.
- Salloum, A., Kondrat, D. C., Johnco, C. & Olson, K. R. (2015). The role of self-care on compassion satisfaction, burnout and secondary trauma among child welfare workers. *Children and Youth Services Review*, 49, 54-61.
- Skakon, J. (2010). Well-being and stress among leaders and employees: how does leader stress affect employee stress and well-being?. Københavns Universitet, PhD afhandling.
- Stamm, B. H. (2003). Professional quality of life: Compassion fatigue and satisfaction subscales, R-III (Pro-QOL).
- Stamm, B. H. (2005). The ProQoL Manual. *The Professional Quality of Life Scale: Compassion satisfaction, burnout, and compassion fatigue/secondary trauma scales*. Lutherville, MD: Sidran Press.
<http://www.compassionfatigue.org/pages/ProQOLManualOct05.pdf>
- Stamm, B. H. (2010). *The concise ProQOL manual* (2nd ed.). Pocatello, ID: ProQOL.org.
http://www.proqol.org/uploads/ProQOL_Concise_2ndEd_12-2010.pdf